

NS E5424A06566

EDSON LEAL JUNIOR

RE 50	PESO: 165	ALTURA: 190	PROFISSÃO: gerente loja (8-18h)
SINTOMAS: sonolência / cansaço / m. II e edema			
QUEIXAS: sensação de cansaço / tossir à noite			
MEDICAMENTOS: xarelto / allopurinol / Furosemida prop.			
TV P em 2000 → uso meia compr. HAS / colesterol			
MÉDICO: Dr. Zampa Trombose pulmonar 2000			
EXERCÍCIO FÍSICO: Musc. (5x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: N			
HORA QUE DORME: 22		HORA QUE ACORDA: 5:30	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: -			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gôbora		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 47 cm	
OVERLAP: não	MALLAMPATI: III	IAH: 104.8	SPO2: 48%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:		30,6 e/hv SpO2 56%	
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
→ dor na planta dos pés.			
07/12 - Adaptação / mais DreamWisp			
23			
21/12 P = 8.8 - 11.6 cmH ₂ O (6-12) Deixo			
23 IAH = 0.7 e/hv 5 rampa			
m. de uso: 5h22			
Fuga = 20.5 fua.			
19/01/24 P = 9.4 cmH ₂ O Perc 11.7			
IAH = 0.3 e/hv			
m. de uso = 7 horas			
fuga = 21.1 min.			
- mais disposto; menos cansado.			
- está dormindo mais cedo.			
Auto 6h à 12 mantendo Silva			
09/02 P = 9.2 cmH ₂ O			
24 IAH = 0.2 e/hv			
m. de uso 6h24			
Fuga = 3.4 med / perc. 24.6 e/hv fua			
29/08 Voltou a utilizar hoje, estava ansioso			
12/11 P = 9.2 cmH ₂ O não está fazendo			
24 IAH = 0.4 e/hv exerc. físico			
01/07 P = 6-10 cmH ₂ O automático			
25 Bem adaptado, porém esquece fua			
de colocar o CPAP			

Comprou um CPAP BMC

05/08 P=6cmH₂O
m. de uso: 3hr
IAH=0,3
Puga=0,5 lpm.

Oriento 4 o uso.

suas clínicas

DR ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Edson Leal Junior

EXAME nº: 5256-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa

DATA: 01/11/2023

IDADE: 50 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h41min e concluído às 05h19min. A latência para o sono foi de 0 minuto e a latência para o estágio REM, de 87 minutos. O tempo total de sono foi de 364,5 minutos (06h04min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,5%. A distribuição do sono mostrou 7% de estágio 1, 55,6% de estágio 2, 21,4% de estágio 3 e 16% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 34 minutos em vigília, ocorreram 58 microdespertares (índice: 9,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 13,7/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 30,6/hora, sendo 1,3 apneia/hora e 29,3 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 30,6/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 87% e a mínima de 56%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa large (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 6 cm de H₂O. De acordo com o relatório da técnica, conforme aumentava a pressão do equipamento, a saturação caía.

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (30,6/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (30,6/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 63; máxima: 79 bpm.

Registraram-se episódios de ronco.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu imediatamente (latência para o sono: 0 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (87 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (91,5%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,5/hora; normal até 15/hora) permaneceram nos limites da normalidade. Houve o aumento da porcentagem do estágio 3 (21,4%; normal: 10-12%) e a redução dos estágios 1 (7%; normal: 8-10%) e REM (16%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (55,6%; normal: 45-55%) permaneceu no limite superior da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (13,7/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730



DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Edson Leal Junior
EXAME nº: 5256
SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa
DATA: 07/11/2022
IDADE: 49 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h21min e concluído às 05h17min. A latência para o sono foi de 2 minutos e a latência para o estágio REM, de 100 minutos. O tempo total de sono foi de 417 minutos (06h57min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 88,5%. A distribuição do sono mostrou 28,8% de estágio 1, 52,8% de estágio 2, 4,7% de estágio 3 e 13,8% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 52 minutos em vigília, ocorreram 358 microdespertares (índice: 51,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 8,5/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 104,8/hora, sendo 33,2 apneia/hora e 71,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 104,8/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 86% e a mínima de 48%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (104,8/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (104,8/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 63; máxima: 85 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 2 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (100 min; normal: 70 a 120 min). Apesar eficiência do sono adequada (88,5%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 51,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 1 (28,8%; normal: 8-10%) e a redução dos estágios 3 (4,7%; normal: 10-12%) e REM (13,8%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (52,8%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (8,5/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 13 (sonolência diurna; normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730